

CAPÍTULO 13.46

Amigdalitis Aguda

PERFIL EUNACOM 1.04.1.025

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La **amigdalitis aguda** es uno de los motivos de consulta más frecuentes en pediatría, otorrinolaringología e infectología. El desafío clínico principal para el examen EUNACOM consiste en diferenciar la etiología **viral** de la **bacteriana**, ya que de esto depende la decisión de iniciar tratamiento antibiótico.

Epidemiología y Etiología

La gran mayoría de las amigdalitis son de origen **viral (90%)**. Solo un pequeño porcentaje (cerca del 10%) son bacterianas, siendo el agente principal el **Streptococcus pyogenes** (Estreptococo beta-hemolítico grupo A).

- **Amigdalitis Viral:** Es la más frecuente en todas las edades, especialmente en menores de 3 años.
- **Amigdalitis Bacteriana:** Su peak de incidencia ocurre entre los **5 y 15 años**. Es muy poco probable en menores de 3 años y en adultos mayores de 45 años.

NOTA CLÍNICA

En niños menores de 3 años con exudado amigdaliano, la causa más probable es el **Adenovirus** y no el estreptococo.

Diferenciación Clínica

La distinción entre ambas se realiza fundamentalmente mediante la historia clínica y el examen físico.

TABLA 13.46.1: CARACTERÍSTICA VS AMIGDALITIS BACTERIANA

CARACTERÍSTICA	AMIGDALITIS BACTERIANA	AMIGDALITIS VIRAL
Inicio	Brusco (horas a 1 día)	Gradual
Dolor	Intenso (odinofagia severa)	Leve a moderado
Fiebre	Alta (>38.5°C)	Variable o ausente
Exudado	En los surcos/criptas amigdalianas	Superficial o ausente
Síntomas Respiratorios	Ausentes (Sin tos, rinorrea ni disfonía)	Presentes (Tos, coriza, rinorrea)
Adenopatías	Cervicales anteriores dolorosas	Generalizadas o ausentes
Otros	Eritema faríngeo importante	Conjunctivitis, aftas, exantema viral

PERLA CLÍNICA EUNACOM

La presencia de **conjuntivitis** asociada a fiebre y faringitis orienta fuertemente a **Adenovirus** (Fiebre faringoconjuntival).

Criterios de Centor Modificados

Para objetivar la sospecha de amigdalitis estreptocócica, se utilizan los **Criterios de Centor Modificados**. Cada criterio suma 1 punto:

- **Temperatura > 38°C.**
- **Exudado amigdaliano** o hipertrofia/eritema marcado.
- **Adenopatías** cervicales anteriores dolorosas.
- **Ausencia de tos** (y otros síntomas catarrales).
- **Edad:**
 - - 3 a 14 años: +1 punto.
 - - 15 a 44 años: 0 puntos.
 - - ≥ 45 años: -1 punto.

Conducta según puntaje:

- **0 - 1 punto:** Riesgo muy bajo. Manejo **sintomático** (viral). No requiere test.
- **2 - 3 puntos:** Riesgo intermedio. Se debe realizar **estudio microbiológico** (Test rápido o Cultivo).
- **4 - 5 puntos:** Riesgo alto. Se puede iniciar **antibióticos empíricos** (aunque la recomendación internacional actual sugiere confirmar con test si está disponible para evitar el uso excesivo de antibióticos).

Diagnóstico Microbiológico

Existen dos herramientas principales:

- **Test de Antígeno Rápido (Pack-A):** Entrega resultados inmediatos. Si es positivo, confirma la infección. Si es negativo en un niño, se debe esperar el cultivo por su menor sensibilidad.
- **Cultivo de Faringe:** Es el **Gold Standard** por su alta sensibilidad y especificidad. Su desventaja es que demora de 24 a 48 horas.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Si el test rápido es negativo pero la sospecha clínica es alta, se debe dejar tratamiento sintomático y esperar el resultado del cultivo para decidir si se inician antibióticos.

Tratamiento Antibiótico

El objetivo del tratamiento en la amigdalitis estreptocócica no es solo acortar los síntomas, sino prevenir complicaciones no supurativas como la **Enfermedad Reumática Activa** (Fiebre Reumática).

Esquemas de Primera Línea

- **Penicilina Benzatina (IM, dosis única):**
 - - < 30 kg: 600.000 UI.
 - - > 30 kg: 1.200.000 UI.
 - - *Ventaja:* Asegura cumplimiento. *Desventaja:* Dolorosa.
- **Amoxicilina (Oral):**
 - - Dosis: 50 mg/kg/día (dividido en 2-3 dosis).
 - - Duración: **10 días estrictos** para erradicar el germen.

Manejo en Alérgicos a Penicilina

- **Alergia NO mediada por IgE (ej. Rash tardío):** Se puede usar **Cefadroxilo** (Cefalosporina de 1ra generación), ya que la reacción cruzada es baja y es más eficaz que los macrólidos.
- **Alergia mediada por IgE (Urticaria, Angioedema, Anafilaxia):** Se utilizan macrólidos como la **Azitromicina** (500 mg/día por 3-5 días) o **Claritromicina**.
- **Intolerancia a Macrólidos:** La **Clindamicina** es una excelente alternativa.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Nunca use Amoxicilina si sospecha **Mononucleosis Infecciosa** (Virus Epstein-Barr), ya que produce un **rash cutáneo maculopapular** característico en casi el 100% de los casos tras la administración del antibiótico.

Situaciones Especiales

Mononucleosis Infecciosa (Virus Epstein-Barr)

Se presenta con una faringoamigdalitis con un **exudado blanco, extenso, grueso y adherente** en la superficie de las amígdalas (no solo en los surcos). Se acompaña de adenopatías cervicales posteriores, axilares e inguinales, además de hepatoesplenomegalia.

Casos Refractarios

Si un paciente no responde al tratamiento inicial con Amoxicilina, se puede considerar el uso de **Amoxicilina + Ácido Clavulánico**.

NOTA CLÍNICA

La refractariedad no suele deberse a resistencia del *S. pyogenes* (que sigue siendo 100% sensible a penicilina), sino a la presencia de bacterias productoras de betalactamasas en la microbiota faríngea que "protegen" al estreptococo.

Amigdalitis Recurrente

En casos de múltiples episodios bacterianos al año (Criterios de Paradise), se debe evaluar la derivación a especialista para considerar una **amigdalectomía**.

Resumen de Virus Asociados

Además de los virus respiratorios comunes, otros virus pueden causar cuadros amigdalinos: - **Adenovirus**: Fiebre alta y conjuntivitis. - **Coxsackie A16**: Herpangina o Síndrome Pie-Mano-Boca (vesículas). - **Virus Herpes Simplex (VHS)**: Gingivostomatitis herpética. - **VIH**: En fase de primoinfección. - **Influenza, Parainfluenza y Virus Sincicial Respiratorio**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Niño de 10 años consulta por odinofagia intensa de 12 horas de evolución, fiebre de 39°C, adenopatías cervicales bilaterales y exudado purulento en los surcos amigdalinos. No presenta tos, rinorrea ni disfonía. ¿Cuál es la conducta más adecuada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Amigdalitis Aguda. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- 90% de las amigdalitis son virales → tratamiento sintomático. Solo las bacterianas requieren antibióticos.
- Amigdalitis bacteriana: dolor intenso, inicio rápido, fiebre >38°C, adenopatías, exudado en surcos, SIN síntomas catarrales ni conjuntivitis.
- Edad típica bacteriana: 5-15 años. Menores de 3 años → sospechar adenovirus. Mayores de 45 → muy improbable bacteriana.
- Exudado blanco, grande, adherente en superficie amigdalina = mononucleosis (Epstein-Barr), NO bacteriana.
- Criterios de Centor modificados: T>38°C, exudado/eritema amigdalino, adenopatías, sin síntomas catarrales, edad 3-15 años (1 punto c/u).
- 0-1 puntos → viral; 2-3 puntos → test rápido + cultivo; 4-5 puntos → antibióticos de inmediato.
- Antibiótico de elección: penicilina benzatina IM (1,2M UI si >30 kg; 600K UI si <30 kg) o amoxicilina 50 mg/kg/día × 10 días.
- No hay resistencia de *S. pyogenes* a betalactámicos.
- Alergia leve no IgE-mediada → cefadroxilo. Alergia severa o IgE-mediada (urticaria, anafilaxia) → azitromicina.
- Casos refractarios → amoxicilina-ácido clavulánico (otras bacterias protegen al estreptococo con sus betalactamasas).

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (AMIGDALITIS AGUDA)

PREGUNTA 1

Niño de 10 años consulta por odinofagia intensa de 12 horas de evolución, fiebre de 39°C, adenopatías cervicales bilaterales y exudado purulento en los surcos amigdalinos. No presenta tos, rinorrea ni disfonía. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Tratamiento sintomático y control en 48 horas
- B)** Solicitar test rápido estreptocócico antes de decidir tratamiento
- C)** Iniciar penicilina benzatina 1.200.000 UI intramuscular
- D)** Iniciar azitromicina 500 mg/día por 5 días
- E)** Solicitar hemograma y monotest para descartar mononucleosis

PREGUNTA 2

Lactante de 8 meses presenta fiebre, odinofagia, adenopatías cervicales y exudado amigdalino bilateral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Amigdalitis bacteriana por *Streptococcus pyogenes*
- B)** Infección por adenovirus
- C)** Mononucleosis infecciosa
- D)** Escarlatina
- E)** Enfermedad de Kawasaki

PREGUNTA 3

Paciente de 12 años con diagnóstico de amigdalitis pultácea. Los padres refieren que desarrolló un rash eritematoso difuso 3 días después de iniciar amoxicilina en un episodio previo. ¿Cuál es el antibiótico más adecuado para este episodio?

- A)** Amoxicilina nuevamente, ya que el rash previo no fue una alergia verdadera
- B)** Cefadroxilo
- C)** Azitromicina
- D)** Clindamicina
- E)** Amoxicilina-ácido clavulánico

RESUMEN: AMIGDALITIS AGUDA

La amigdalitis aguda es un tema frecuente en el EUNACOM, apareciendo tanto en otorrinolaringología como en pediatría e infectología. La clave clínica es diferenciar la amigdalitis bacteriana de la viral, ya que solo la bacteriana requiere antibióticos. El 90% de las amigdalitis son virales y se manejan con tratamiento sintomático exclusivamente. La amigdalitis bacteriana se caracteriza por dolor intenso de inicio rápido (horas a un día), fiebre alta (>38°C), adenopatías, exudado en los surcos amigdalinos, eritema faríngeo intenso y ausencia de síntomas catarrales (tos, disfonía, rinorrea) ni conjuntivitis. Ocurre típicamente entre los 5 y 15 años; en menores de 3 años es muy improbable (sospechar adenovirus) y en mayores de 45 también es rara. Un exudado blanco, grande y adherente en la superficie amigdalina sugiere mononucleosis (Epstein-Barr), no bacteria. Los criterios de Centor modificados (5 puntos) guían el manejo: temperatura >38°C, exudado/hipertrofia/eritema amigdalino, adenopatías, ausencia de síntomas catarrales y edad 3-15 años. Con 0-1 puntos se asume viral (tratamiento sintomático); con 2-3 puntos se solicita test rápido estreptocócico y cultivo; con 4-5 puntos se asume bacteriana y se inician antibióticos de inmediato. El antibiótico de elección es penicilina benzatina (1,2 millones UI IM si >30 kg; 600.000 UI si <30 kg, dosis única) o amoxicilina (50 mg/kg/día por 10 días). No existe resistencia del *Streptococcus pyogenes* a betalactámicos. En alérgicos leves no mediados por IgE se usa cefadroxilo; en alergia severa o mediada por IgE se indica azitromicina. La clindamicina es opción ante intolerancia a macrólidos. En casos refractarios se evalúa amoxicilina-ácido clavulánico.